Fistules vésico utérines au Burkina Faso : aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques

Nom du présentateur : PARE Abdoul-Karim

Auteurs et coauteurs : Yé D, Ki GT, Simporé M, Bako A, Ouédraogo I, Ouédraogo D, Yaméogo CMD, Kirakoya B, Ouattara A, Kaboré AF

Affiliations : Service d'Urologie, CHUSS de Bobo-Dioulasso

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- Fistule vésico-utérine: communication anormale entre la vessie et l'utérus
- Prévalence: rare, 1-4% des fistules urogénitales
- Clinique: perte involontaire des urines , hématurie cyclique
- Etiologie: iatrogène au décours d'une chirurgie pelvienne
- Traitement : chirurgical

Objectif

Décrire les aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques de la fistule vésico-utérine au Burkina Faso

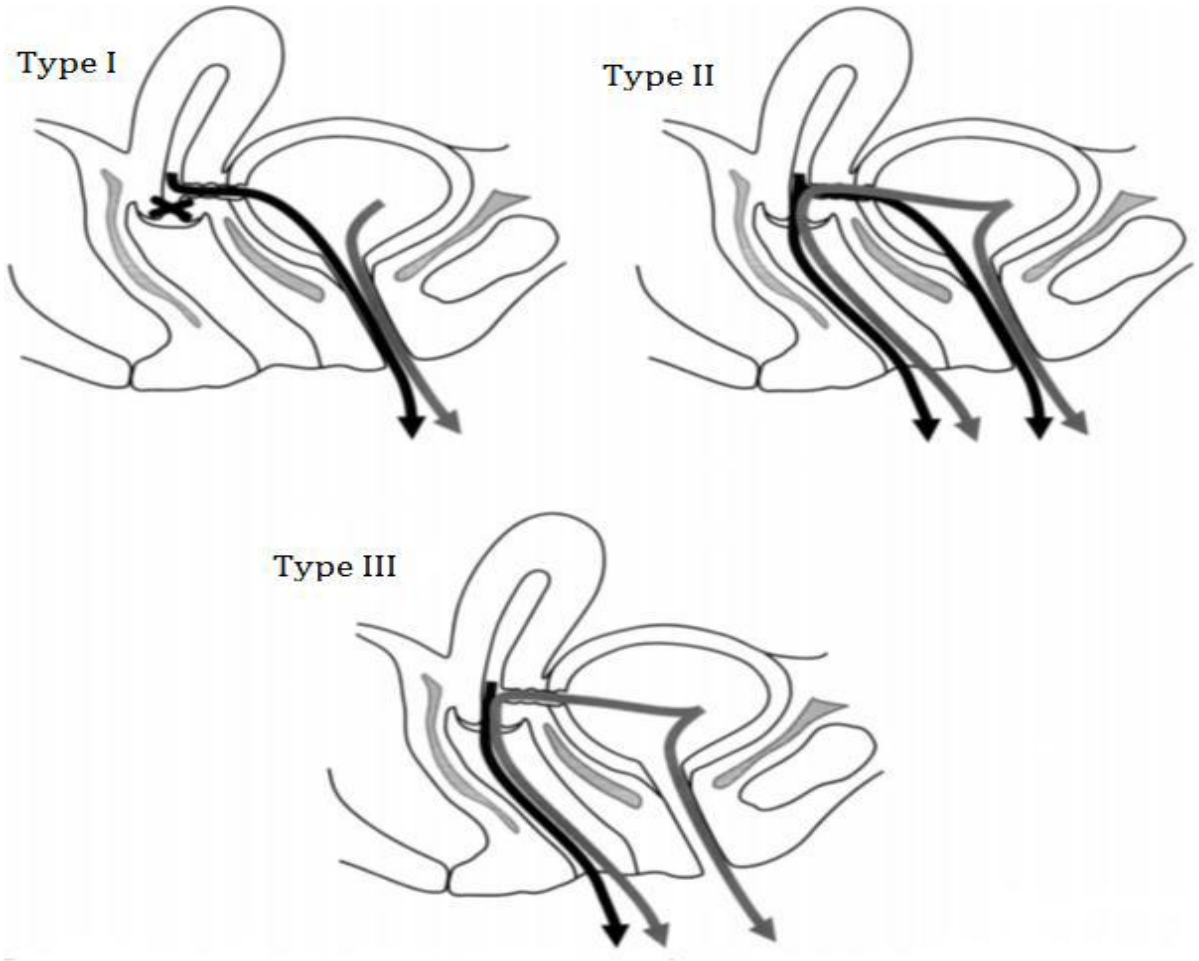
Matériel et méthode(s)

- Etude rétrospective descriptive sur une période de 14 ans (janvier 2010 - décembre 2023)
- Services d'Urologie du CHUSS de Bobo Dioulasso et du CHUYO de Ouagadougou, l'hôpital protestant Schiphra et le Centre Médical Renaissance
- Echantillon: patients hospitalisés et prise en charge pour FVU

Matériel et méthode(s)

- Fiche de collecte/sources de données
- Variables étudiées
  - Données sociodémographiques
  - Données cliniques, paracliniques
  - Modalités thérapeutiques et évolutives

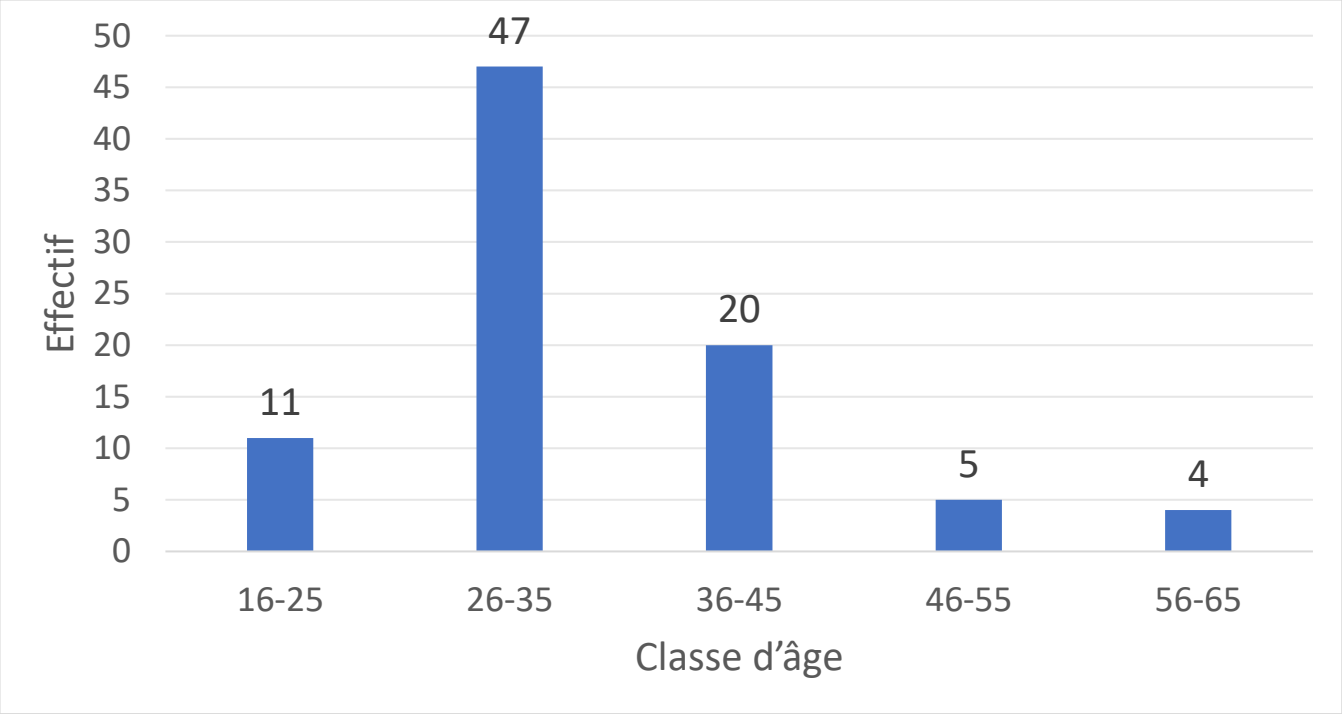
Matériel et méthode(s)



Classification clinique des fistules vésico-utérines (**Jozwik)**

Résultats

- **Prévalence:** 7,3% (87 FVU vs 1178 FUG)
- **Age moyen**: 33,6 ans [25 ans et 42 ans]
- **Femme au foyer** : 91%
- **Milieu rural** : 66%
- **Multipares** : 41%



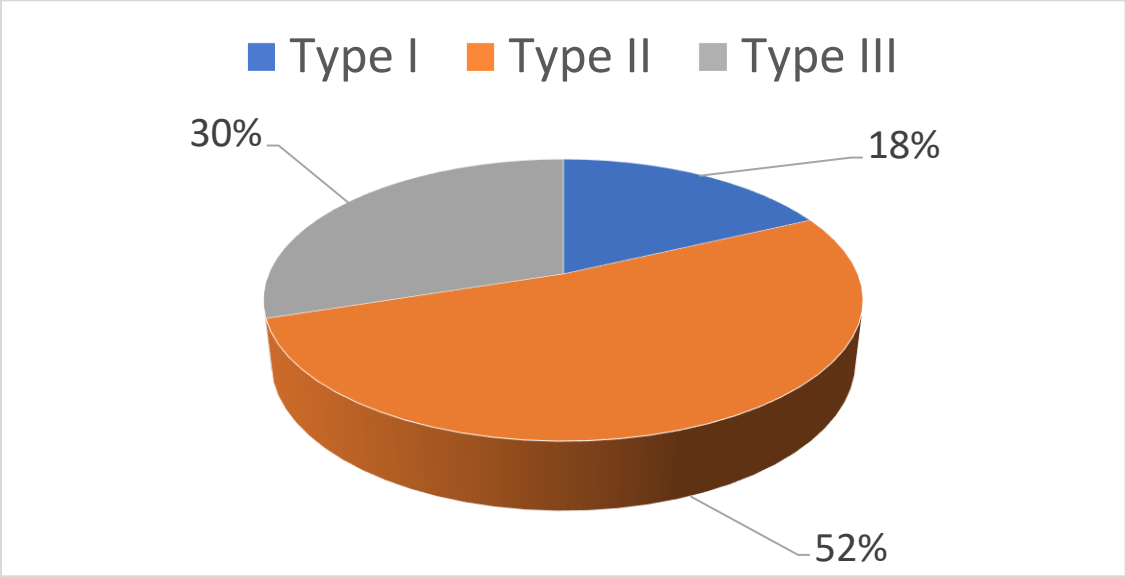
Résultats

- **Interrogatoire**
  - ✓**Durée d'évolution** : 2,6 ± 3,5 ans [2 jours -31ans]
  - ✓**Motif de consultation**

    Hématurie cyclique (12 %),

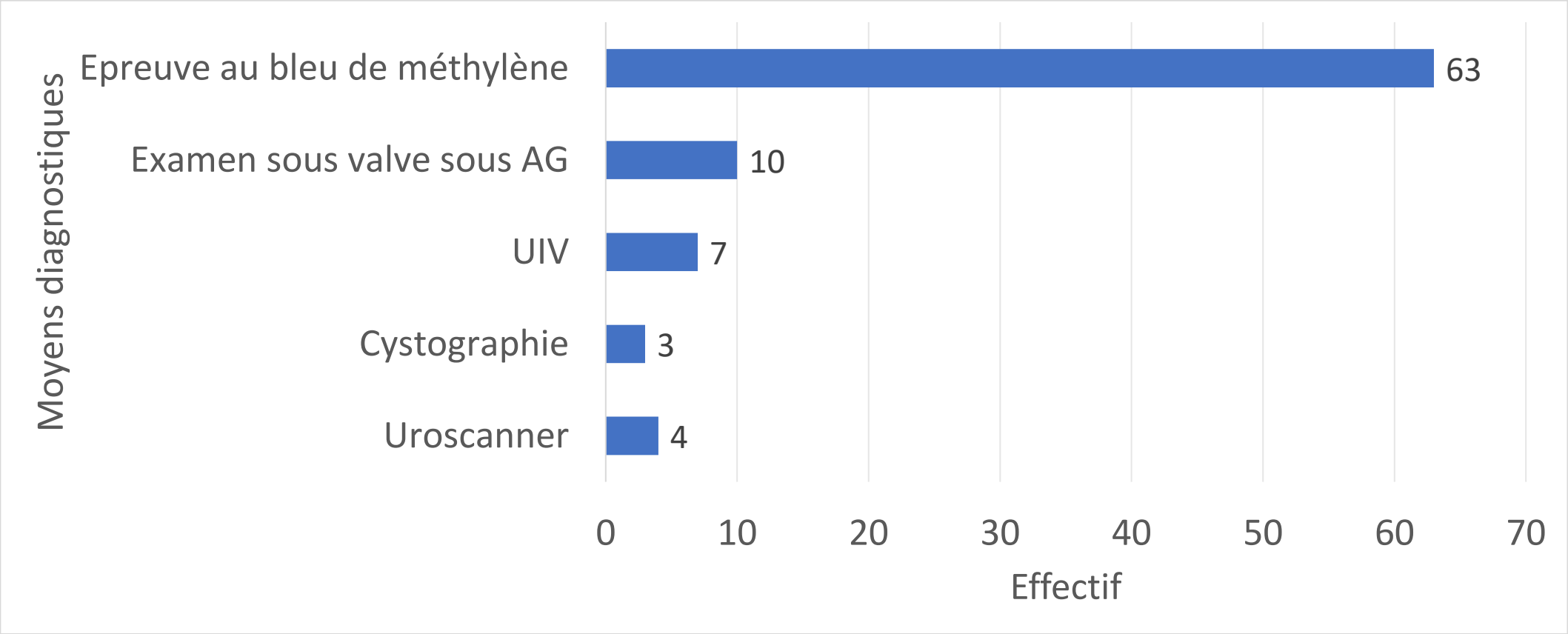
    Fuite d'urines par le vagin (88%)

- **Classification de Jozwik**



Résultats

- **Moyens diagnostiques**



Résultats

- **Etiologies de la fistule**

Cause de la fistule	Fréquence (n)	Pourcentage (%)
Césarienne	59	68%
Accouchement dystocique	**27**	**31%**
Post hystérectomie	1	1%
Total	**87**	**100%**

- **Lésions associées**

Fistule vésico vaginale (22%) et atteinte de l'urètre (2%)

Résultats

- **Traitement**
  - ✓ **Voie d'abord:** haute (83%) basse (15%) mixte (2%)
  - ✓Dissection cloison vésico utérine et suture séparée : 89,6%
  - ✓**Hystérectomie** : 10,4 %

- **Gestes associés**
  - ✓Extraction calcul vésical : 2 cas
  - ✓Cure fistule vésico vaginale : 18 cas
  - ✓Urétroplastie : 2 cas

Résultats

- **Suites post opératoires**
  - ✓**Durée moyenne port de la sonde** :12,9 ± 6 jours [3-23]
  - ✓**Suites simples** : 94,2%
  - ✓**Complications** : 5,8% (infection urinaire 1 cas, suppuration 1 cas, hématurie 1 cas)

Résultats

- **Résultats**

Résultats à la sortie	Fréquence (n)	Pourcentage (%)
Succès	75	86%
Echec	7	8%
IU	5	6%
Total	**87**	**100%**

- **Durée moyenne d'hospitalisation:** 25,9 ± 16,3 jours [3-120 jours]

- **Reprise des menstrues vaginales** : 9/12 (75%) avec aménorrhée

Conclusion

- Les FVU sont les plus rares des fistules urinaires

  Etiologie essentiellement obstétricale

- Diagnostic → présence de communication entre les deux organes

- Reconnues et correctement opérées → guérison

- Prévention: accès aux soins plus rapide et amélioration de la qualité de la césarienne

Merci pour votre attention